

Обоснование сохранения актуальности изучаемой в рамках Проекта 2023 научной проблемы.

Проблема сохранения и развития человеческого потенциала остается одной из самых актуальных для современной России. Низкий уровень рождаемости сопровождается на протяжении последних лет низким уровнем ожидаемой продолжительности жизни россиян (прогнозное значение 2025 г. – 73,5 года (для мужчин – 67,7 лет, для женщин – 79,3 лет), что соответствует 112 месту среди стран мира) [World Bank, 2024] и маркирует серьезный демографический кризис. Заложенная в национальном проекте «Здравоохранение» цель обеспечения устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации и повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 г. не достигнута.

По инициативе Президента РФ в 2025 году стартовали новые национальные проекты, призванные обеспечить достижение амбициозных целей в сфере здоровья и долголетия. Так, национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» предусмотрено «увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 г. и до 81 года к 2036 г., в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни». Ключевым механизмом достижения целей называется цифровизация здравоохранения, являющаяся, с одной стороны, важным ресурсом изменения самосохранительных стратегий россиян, с другой, источником зон риска, требующих превентивных научно обоснованных мер и решений. Можно выделить три ключевых противоречия, определяющих актуальность продолжения социологического осмысления самосохранительных стратегий россиян в условиях новой нормальности.

1. Амбивалентность цифровой реальности как новой нормальности (противоречие «цифровые ресурсы заботы vs новые риски»). Цифровизация здравоохранения (понимаемого в широком смысле, не только как государственная система оказания медицинской помощи) – единый цифровой контур здоровья, телемедицина, внедрение искусственного интеллекта, дистанционный мониторинг, электронный документооборот и пр. – предполагает не только трансформацию медицины и управления отраслью через внедрение информационных технологий, но и а) изменение самой логики «врач – пациент – государство», б) интеграцию (опосредованную содержанием современных социальных ролей и нормативными ожиданиями) цифровых технологий в повседневные практики заботы о здоровье [Богомякова, Е.С., 2022]. Из пассивного объекта воздействия системы здравоохранения индивид становится активным субъектом, способным реализовывать заботу о физическом и ментальном благополучии в ежедневном режиме. При этом а) ориентация на цифровые инструменты заботы о здоровье («гаджеты для здоровья») приводит к кризису субъектности, когда ответственность за здоровье и безопасность перекладывается на алгоритмы, б) сохраняется высокий риск дезинформации и ошибочных самосохранительных решений в условиях высоко интенсивного информационного потока, в) проявляется «конфликт приватности» (необходимость «информационного раскрытия» в условиях высокого риска утечки данных).
2. Цифровая реальность, являясь неоднородной, создает новые формы социальной эксклюзии и зоны уязвимости (противоречие «инклюзивность vs дискриминационность цифровой среды»). «Цифровая забота» доступна имеющим ресурсы (материальные, информационные), но не уязвимым группам (пожилые люди, малообеспеченные, жители отдаленных районов, люди с инвалидностью), являющимся «цифровыми аутсайдерами» (антиподами

«цифровых аборигенов» в терминологии М. Пренски [Prensky, M., 2001]. Цифровое неравенство усиливает неравенство в здоровье, что в условиях глобальной ориентации на цифровое здравоохранение становится не только локальным, но транснациональным вызовом [Региональный план действий в области цифрового здравоохранения для Европейского региона ВОЗ на 2023–2030 гг., 2022]. Новые виды угроз – кибермошенничество, дезинформация (например, «цифровое целительство») – более значимы именно для уязвимых групп, не имеющих достаточных ресурсов для противодействия им. В контексте изучения положения уязвимых групп цифровую среду можно трактовать не как источник стабильности, но как новый формат выживания, формирующий дополнительные риски.

3. В условиях интенсивной цифровизации формируется принципиально новая «дефицитарная зона» – ментальное благополучие (противоречие «вовлеченность vs уязвимость»). Цифровая среда становится источником постоянного стресса, информационной перегрузки – возникает «цифровой стресс» [Hefner, D., Vorderer, P., 2016]. Медиасреда с большим выбором [Казун, А.Д., 2024] формирует повышенную тревожность вследствие «парадокса выбора» [Schwartz, B., 2003], когнитивную перегрузку, повышает риск развития депрессии и ухудшения когнитивных функций. В интенсивно цифровизирующемся обществе формируется высокий запрос на адаптационные ресурсы, поддерживающийся индивидуализацией, потерей социальных связей, кризисом идентичности и высоким уровнем рискогенности социальной среды [Whitley, R., 2008]. Если физическая безопасность обеспечивается внешними системами контроля, то ментальное благополучие становится наименее защищенным сегментом в структуре самосохранения россиян. Более того, формируется своеобразный парадокс заботы – для обеспечения ментального здоровья в новой цифровой нормальности индивиду требуется контролировать и ограничивать использование тех цифровых ресурсов, которые призваны ему помогать. Таким образом, научная проблема, поставленная в Проекте-2023, может быть развита через призму трактовки новой нормальности как цифровой реальности, преломляющей и видоизменяющей самосохранительные практики россиян, являющейся источником новых ресурсов и рисков, амбивалентным пространством сокращения и усиления неравенства в сфере здоровья и безопасности.

Новые задачи, которые предполагается решить в рамках Проекта 2026, их научная значимость, масштабность и новизна. Взаимосвязь Проекта 2026 с Проектом 2023, обоснование их научного единства.

Результаты Проекта 2023 создают важный контекст для осмысления противоречий, формируемых интенсивной цифровизацией сферы заботы о здоровье и безопасности.

1. По итогам Проекта 2023 установлено, что актуальные практики и стратегии заботы россиян о своем здоровье и безопасности (самосохранительные стратегии) частично трансформировались под воздействием эпидемиологических, социально-политических и социально-экономических контекстов, но по-прежнему базируются на восприятии здоровья как инструментальной ценности. Пандемия COVID-19 оказала лишь временное воздействие на ценности здоровья, не затронув фундаментальных паттернов самосохранительного поведения россиян. При этом инструменты реализации самосохранения активно видоизменяются, предполагая иную, активную роль человека в заботе о здоровье, повышают его субъектность. Но может ли цифровизация стать тем фактором, который выведет ценность здоровья на новый уровень? Как цели и задачи цифровизации сферы здравоохранения, заложенные в стратегических документах, могут быть достигнуты в условиях доминирования пассивных самосохранительных стратегий, низкой мотивации на самозаботу? Является ли «откат» к допандемийным практикам признаком культурной резильентности или это упущенный шанс на качественное изменение отношения россиян к собственному здоровью? Цифровизация здравоохранения приводит к размытию институциональных ролей, при котором традиционные границы между экспертным медицинским знанием (врач, государство), коммерческим предложением (производители гаджетов), личным опытом (пациентские сообщества) и медийным влиянием (блогеры) становятся проницаемыми. Это порождает новую систему неявной ответственности и обобщенных анонимизированных советов, что повышает риски для здоровья людей, выстраивающих свои стратегии самосохранения, принимающих решения относительно здоровья и действующих в среде с неопределенными правилами.
2. Особый фокус исследования в рамках Проекта 2023 был направлен на уязвимые группы (люди с инвалидностью, пожилые, малообеспеченные). Установлены специфические факторы, определяющие их выборы в сфере здоровья и безопасности, и необходимость учета особенностей повседневного поведения, уровня социального капитала и адаптации при описании стратегий самосохранения. С одной стороны, цифровые ресурсы призваны повысить инклюзию данных групп, но, возможно, цифровизация является дополнительным источником дискриминации. И тогда, чем больше здравоохранение и системы обеспечения безопасности становятся цифровыми, тем сильнее от этих новых ресурсов заботы отчуждаются те, кто не обладает цифровыми компетенциями или иными ресурсами доступа к цифровой среде.
3. Анализ целей и практик заботы о россиянах о ментальном здоровье в рамках Проекта 2023 показал, что, несмотря на рефлекссию пандемии как источника тревожности и стресса, вопросы заботы о психическом здоровье не стали

первоочередными для населения. Рост геополитической напряженности, усложнение общественно-политической ситуации в мире, начало СВО стали факторами некоторого усиления внимания россиян к тематике ментального здоровья, однако данное усиление не носит принципиального характера. Нарративы представителей всех возрастных групп о ментальном здоровье в «постпандемию» выстраиваются в преимущественно рефлексивном ключе – описание психоэмоциональных состояний сочетается с определением факторов влияния, но не включает способы защиты от них. «Цифровой маятник» между расширением возможностей в сфере заботы о ментальном здоровье и ростом вариативности факторов риска его ухудшения ставит вопросы а) о границах адаптационных возможностей индивида и способности в рамках актуальных самосохранительных стратегий предотвратить угрозы ментальному здоровью, продуцируемые цифровой средой, б) о фактической роли цифровой медиатизации заботы – как фактора укрепления ментального здоровья (через формирования устойчивости) или механизма формирования иллюзии защищенности, маскирующего рост «ментальной прекаризации».

В рамках Проекта 2026 предполагается ответить на следующие исследовательские вопросы:

Во-первых, является цифровизация сферы заботы о здоровье и безопасности фактором реальной трансформации самосохранительного поведения россиян или она лишь создает технологический интерфейс для воспроизводства традиционных прагматических стратегий? Формирует ли цифровизация стимул к ценностному обновлению или выступает лишь средством компенсации дефицитов традиционной системы здравоохранения, что закрепляет выявленные ранее типичные паттерны заботы о здоровье и безопасности? (линия «Практики и стратегии»)

Во-вторых, как появление новых акторов (врачей-блогеров, анонимных пользователей на форумах, алгоритмических рекомендаций приложений, искусственного интеллекта (ИИ), производителей гаджетов и т.п.) меняет логику взаимоотношений «пациент – врач – государство», как происходит перераспределение доверия между акторами (кому и почему люди доверяют свое здоровье?)? Как вследствие всего этого происходит принятие решений относительно здоровья? (линия «Акторы»)

Во-третьих, как цифровая реальность трансформирует стратегии самосохранения уязвимых групп населения: выступает ли она ресурсом преодоления институциональных, организационных и иных барьеров, или становится дополнительным источником рисков и углубления неравенства в сфере здоровья и безопасности? (линия «Неравенство»)

В-четвертых, как цифровая среда, формирующая новые риски для ментального здоровья граждан, трансформирует их самосохранительное поведение? Являются ли данные риски осознаваемыми, какова специфика их субъективного восприятия? Что собой представляют практики цифровой гигиены и насколько они дифференцированы в различных социальных группах? (линия «Уязвимость»)

Задачи исследования и исследовательские гипотезы.

Задача 1. Описать характер влияния цифровизации на самосохранительные практики и стратегии россиян и определить, способствует ли она качественному обновлению ценностных оснований, направляющих поведение и выборы в сфере здоровья и безопасности или выступает инструментом консервации прагматических стратегий.

Гипотезы: 1. Цифровые ресурсы воспринимаются населением не как инструменты перехода к проактивной заботе о здоровье и безопасности, но а) как механизмы компенсации дефицитов традиционной системы здравоохранения, б) как атрибуты символического потребления. Использование цифровых инструментов заботы о здоровье носит поверхностный, имитационный и технический характер; цифровой мониторинг ритуализируется, лишаясь самосохранительного эффекта, а самосохранительное поведение геймифицируется, принимает характер перформативного. 2. Внедрение искусственного интеллекта в повседневные практики заботы о здоровье и личной безопасности не формирует «новую ответственность», опосредованную «цифрой», усиливает прагматический расчет, подкрепляя инструментальное отношение россиян к здоровью.

Задача 2. Охарактеризовать роль новых акторов пространства самосохранения в модификации самосохранительных практик и стратегий россиян; показать вклад искусственного интеллекта (в т.ч. генеративных моделей ИИ) в формирование информационных и когнитивных оснований самосохранения.

Гипотезы: 1. В цифровой среде самосохранительные стратегии основаны на поиске эмпатии. Человек доверяет не институтам, а инфлюэнсерам, с которыми выстраивает парасоциальные отношения, поэтому решения о здоровье принимаются на основе личных симпатий и эмоционального отклика. 2. Новые акторы действуют вне системы подотчетности «врач – государство» (лицензии, юридическая ответственность и пр.), когда вступают в коммуникацию с аудиторией, что приводит к чрезмерной индивидуальной ответственности человека за свое здоровье, для которой он недостаточно компетентен, поэтому наиболее распространенной будет стратегия аутсорсинга ответственности, выбранным авторитетным актором. 3. Коммерциализация сферы здоровья и маркетинговые приемы в распространении товаров приводят к тому, что человек осуществляет выбор методов лечения и профилактики не по медицинскими показаниям, а в зависимости от эффективности коммерческих предложений, не учитывая даже своих индивидуальных контекстов (ему кажется, что продукт / совет предназначен именно для него, хотя это как правило усредненный, универсальный продукт / совет). 4. В цифровой среде возникает новая самосохранительная стратегия, основанная на взаимодействии с ИИ, доверие к которому конструируется на сочетании его восприятия как машины, лишенной человеческих предубеждений, усталости, коммерческого интереса и ограниченности знаний одного конкретного врача, с одной стороны, с другой, как приватного, не осуждающего собеседника (в отличие от врача, ИИ не вынесет моральной оценки; в отличие от форума, диалог с ним полностью конфиденциален). Это делает его идеальным инструментом для получения быстрых ответов и обсуждения деликатных или «стыдных» тем, но полностью выводит процесс принятия решений из поля институциональной и социальной ответственности, делегируя его ИИ, чьи рекомендации не верифицированы, а последствия их применения ложатся исключительно на самого человека.

Задача 3. Типизировать стратегии самосохранения уязвимых групп в условиях интенсивной цифровизации здравоохранения, определить баланс между цифровым ресурсом и цифровыми рисками в их стратегиях.

Гипотезы: 1. Разрыв в цифровых компетенциях создает новые формы уязвимости: стоимость гаджетов и подписок на сервисы мониторинга здоровья создает барьеры для входа уязвимых групп в цифровое пространство заботы о здоровье, низкий уровень цифровой грамотности формирует риски дезинформации и создает зоны для манипуляции. 2. Выход из лакуны «цифровых аутсайдеров» дает возможности получения уязвимыми группами инструментов обхода институциональных барьеров реализации самосохранительных стратегий, способствуют усилению их автономии.

Задача 4. Определить механизмы, посредством которых субъективное осознание рисков цифровой среды для ментального благополучия трансформируется в дифференцированные практики цифровой гигиены как новую форму самосохранительного поведения. Описать роль цифровой медиатизации заботы в формировании моделей самосохранения.

Гипотезы: 1. Наблюдается сдвиг в реакции на цифровые риски – с защиты устройств на защиту личности, однако он неодинаков в различных социальных группах и преломляется уровнем цифровой грамотности. Чем ниже уровень включенности индивида в цифровую среду, тем скорее он будет преувеличивать технические риски и недооценивать когнитивные. 2. В условиях хронического дефицита психоэмоциональных ресурсов, определяемых высокой интенсивности информационных потоков и неопределенностью социальной среды, самосохранительные решения в области ментального здоровья сводятся к упрощенным стратегиям цифрового эскапизма и защитного игнорирования, что, снижая риски в краткосрочной перспективе, не способствует реализации долгосрочным целям самосохранения. 3. Использование гаджетов для здоровья мотивировано потребностью обрести чувство контроля над своим телом и эмоциями через их квантификацию (оцифровку). Переводя неопределенные внутренние ощущения (усталость, тревога) в понятные и измеримые метрики (оценка сна, уровень стресса, количество шагов), индивид создает иллюзию управления и предсказуемости. Но эта стратегия подменяет реальную телесную и эмоциональную рефлексию ритуальным взаимодействием с данными, что не приводит к изменению стрессогенных привычек, а лишь создает видимость заботы о себе, формирует замкнутый цикл зависимости, где решение поставляется той же средой, что и проблема, приводя к «геймификации» (достижению цифровых целей), а не к реальному благополучию. Это порождает новую форму цифровой тревожности, связанную с необходимостью соответствовать «нормальным» показателям гаджета и страхом перед «плохими» данными.

Научная новизна исследования заключается в переходе от анализа цифровых технологий как вспомогательных решений в заботе о здоровье и благополучии к анализу изменения субъектности, осмыслению того, как меняются все элементы стратегии самосохранения под влиянием цифровизации. Цифровая среда рассматривается как «новая среда обитания», формирующая не только риски и возможности, но и специфические практики реагирования на них. Впервые на российском материале будет дана целостная характеристика индивидуальных стратегий поведения в сфере здоровья и личной безопасности в условиях медиатизации заботы, принимающих гибридный характер, сопровождающихся распространением новых форм прекаризации и неравенства.

Предлагаемые методы и подходы, общий план работы на весь срок выполнения Проекта 2026 и ожидаемые результаты (объемом не менее 2 стр. (и не менее 3500 знаков без учета пробелов); в том числе указываются ожидаемые конкретные результаты по годам; общий план дается с разбивкой по годам)

Широкий теоретический контекст исследования формирует концепция цифрового общества (М. Кастельс, Я. ван Дейк), во многом носящая проблемный методологический характер и отсылающая к разнонаправленным явлениям и процессам [Багдасарьян, Н.Г., Кравченко А.Л., 2023]. Цифровое общество понимается как общество, инфраструктура которого функционирует посредством цифровых информационно-коммуникационных технологий, а базовой формой организации и социального взаимодействия являются сети [Добринская, Д.Е., 2019]. Цифровизация, как ключевая тенденция в развитии современного общества, определяющаяся процессами информатизации и компьютеризации, трактуется в рамках проекта как трансформация технологического уклада посредством внедрения современных цифровых технологий во все сферы общественной жизни. Процессом, сопутствующим цифровизации, является «глубокая медиатизация» [Нерр, А., 2020] – возрастающая значимость алгоритмов, данных и искусственного интеллекта для понимания социальной реальности и принятия решений.

Отправной точкой исследования является тезис об амбивалентном влиянии цифровизации на индивидуальное и общественное здоровье как, с одной стороны, увеличивающей возможности индивида в реализации самосохранительных стратегий [Schüll, N., 2016], а с другой, создающей новые риски [Amoore, L., 2020]. Теоретическая рамка исследования формируется концепциями общества риска и рискогенности современных технологий [Beck, U., 1994; Turkle, Sh., 2021], критическими теориями социологии здоровья [Lupton., D. 2024; Conrad., P., 2018] и социологии e-Health [Eysenbach, G., 2022; Nettleton, S., 2022]. Центральными категориями исследования, помимо самосохранительного поведения и стратегии самосохранения, обоснованными в рамках Проекта 2023, выступают «цифровая среда здоровья», понимаемая как пространство социальных отношений, власти и неравенства, «цифровой ресурс здоровья», интерпретируемый не просто как набор гаджетов и приложений, но как цифровые компетенции и технологические возможности, которые индивид может конвертировать в улучшение своего физического здоровья и ментального благополучия, «новые акторы самосохранения» – не только люди, но и технологические сущности, участвующие в принятии решений относительно здоровья и безопасности индивида.

Исследовательская логика эмпирического изучения самосохранительных стратегий россиян в условиях цифровизации построена на трех последовательных и взаимодополняющих уровнях анализа:

1. Дискурсивный уровень фокусируется на нарративах и субъективных интерпретациях индивидов (ключевой вопрос – что сами индивиды сообщают о своем самосохранительном поведении в цифровой среде?)
2. Бихевиоральный уровень строится на эмпирически наблюдаемых актах поведения индивидов (ключевой вопрос – как индивиды ведут себя в цифровой среде относительно вопросов самосохранения?).

3. Контекстуальный уровень – исследование роли цифрового актора в поведении индивида (ключевой вопрос – как новые акторы самосохранения проявляются в пространстве заботы).

Эмпирическую базу исследования составят данные, собранные как традиционными, так и новыми методами:

1. Формализованный онлайн-опрос, репрезентирующий население России в возрасте 18 лет и старше, пользующееся интернетом (не реже 1 раза в неделю). Квотный отбор по критериям пола, возраста, типа поселения и федерального округа. Объем выборки – не менее 2400 человек; способ отбора респондентов – ривер-сэмплинг. Инструментарий исследования размещается на специализированной платформе <https://questionstar.ru/>, апробированной в ходе опроса жителей мегаполисов в Проекте 2023. Структура анкеты будет включать следующие блоки: 1. Ценности и смыслы самосохранения (повторение вопросов, валидизированных в рамках опроса в Проекте 2023), 2. Цифровизированные практики заботы (проактивные и защитные; частота, регулярность), 3. Цифровая гигиена (индекс цифровой зрелости, рефлексия рисков (характеристика уровня субъективно воспринимаемого риска ментальному здоровью на основе авторского подхода). В рамках опроса для измерения и сравнения относительного веса (авторитетности) различных источников информации о здоровье и личной безопасности в контролируемых условиях будет применен метод виньеток: а) создание виньеток, описывающих распространенную, но некритическую проблему со здоровьем. Далее на основе винетки формулируется одна и та же рекомендация, но подается от имени шести разных источников: 1. Традиционный (рекомендация от врача-терапевта из районной поликлиники). 2. Медийный (рекомендация от известного врача-блогера (более 500 тыс. подписчиков), специалиста по доказательной медицине). 3. Алгоритмический (рекомендация, сгенерированная популярным ИИ-ассистентом, таким как ChatGPT или Gemini, на основе ваших симптомов). 4. Коллективный (самый популярный совет по вопросу на крупном форуме о здоровье, поддержанный десятками пользователей). 5. Институционально-государственный (рекомендация с официального портала Министерства здравоохранения РФ). 6. Контрольный (без указания источника) («вот одна из возможных рекомендаций по вашему вопросу»); б) выборка случайным образом делится на 6 групп (в конструкторе опроса используются функции логики ветвления и рандомизации). Каждая группа видит только один из шести вариантов рекомендации (респонденты должны оценить рекомендацию по нескольким 5-балльным шкалам: Насколько вы доверяете этому совету? Насколько этот источник кажется вам компетентным? С какой вероятностью вы бы последовали этому совету?). На этапе анализа данных с помощью дисперсионного анализа (ANOVA) сравниваются средние оценки по всем пяти группам. Для решения задачи описания характера влияния цифровизации на самосохранительные практики и стратегии россиян будут использоваться различные методы анализа данных, начиная от описательной статистики и заканчивая многомерными методами. Цифровизированные практики заботы о здоровье послужат основой для типологизации поведения россиян с использованием теории нечетких множеств, которая отвергает жесткую классификацию, предлагая неисключающую принадлежность объектов к различным группам, что помогает в определении «чистых» и «пограничных»,

«гибридных» типов. Анализ проводится в два этапа: 1) двухэтапный кластерный анализ (Two-Step Cluster Analysis); 2) взвешенный дискриминантный анализ (Weighted Discriminant Analysis) со степенями принадлежности в качестве весов. Жизнеспособность и аналитическая мощь данной двухэтапной процедуры подтверждена ее успешной апробацией в рамках Проекта 2023. Смысловая интерпретация типов также будет дополнена статистическим сравнением по ценностям и восприятию рисков и корреляционным анализом (коэффициент хи-квадрат (χ^2) для номинальных переменных, коэффициенты Пирсона (r) и Спирмена (ρ) для метрических и порядковых данных соответственно). Для более глубокого анализа корреляций будет применена нейросетевая процедура многослойного перцептрона (Multilayer Perceptron, MLP), где в качестве предикторов выступают показатели цифровой зрелости, социально-демографические характеристики, ценности в сфере здоровья, восприятие рисков, а в качестве выходных переменных – конкретные цифровые практики. Основным преимуществом MLP является выявление сложных нелинейных корреляций, которые не устанавливаются классическими коэффициентами. Структура индекса цифровой зрелости будет верифицирована с помощью факторного анализа, внутренняя согласованность всех составных шкал в индексе будет проверена через коэффициент альфа Кронбаха (α).

2. Глубинные интервью с представителями трех типологических групп, выделенных по критерию интенсивности использования цифровых ресурсов самосохранения – «цифровые исключенные (аутсайдеры)», «нерегулярные пользователи (в т.ч. вынужденные)», «активные пользователи» (в т.ч. цифровые энтузиасты в уязвимом положении). Поскольку «цифровой след» каждой из типологических групп различен, для поиска информантов будет применяться смешанная стратегия: а) полевой рекрутинг в публичных местах, типичных для посещения «цифровыми исключенными» (поликлиники, почта, центры социальной поддержки населения) и через гейткиперов – сотрудников референтных НКО, б) онлайн-рекрутинг в наиболее посещаемых пабликах в социальных сетях (городские паблики, «Подслушано» и пр.), в) онлайн-рекрутинг в сообществах биохакеров, форумах по здоровью и пр. Объем выборки будет определяться принципом теоретического насыщения.

Глубинные интервью будут сопряжены с методом стимулированного логирования (Digital tracing) через добровольный экспорт цифровой истории. Информантам будет предложено экспортировать историю за последние 6 месяцев: анонимизированная история поисковых запросов (экспорт из Google/Яндекс-аккаунта), скриншоты или список установленных приложений, связанных со здоровьем и благополучием, добровольный дневник использования ключевых приложений (например, статистика активности из Apple Health/Google Fit). Информант полностью контролирует объем и границы предоставляемых данных, что решает этическую проблему приватности и превращает его из пассивного объекта в активного со-исследователя своего цифрового следа. Цифровая история позволит расширить контекст беседы, обсудить реальные ситуации обращения к цифровым ресурсам для решения вопросов в сфере здоровья. В результате будет сформирована серия детализированных цифровых биографических кейсов, которые раскроют глубокое понимание того, как цифровизация вплетается в ткань повседневных самосохранительных стратегий современного человека.

3. Глубинные интервью с представителями уязвимых групп, дополняющие результаты, полученные в рамках Проекта 2023, и развивающие идею построения

укорененной в данных теории самосохранительных стратегий уязвимых групп. Выборка – многокритериальная. Отдельно будут представлены три подгруппы – люди с инвалидностью, пожилые, малообеспеченные. В выборку исследования войдут частично информанты, принимавшее участие на предыдущих этапах проекта. Интервью будут сопровождаться картографированием рисков и ресурсов цифрового пространства. Информантам будет предложено распределять карточки с различными цифровыми ресурсами (например, чат с врачом, электронная запись к врачу, сервисы помощи (типа сервисы помощи незрячим и слабовидящим Be My Eyes) и пр.) на поле, разделенном на две зоны – «зона опоры / ресурсов» и «зона тревоги / риска». Это позволит представить визуальный профиль цифровой вовлеченности и восприятия цифровой среды в рамках различных самосохранительных стратегий.

4. Метод самоотчетов в реальном времени с целью картографирования цифрового поведения. Карта будет построена по трем осям – цифровые ландшафты (социальные сети, медицинские чаты, приложения, специализированные сайты и пр.), интенсивности и пути (как человек перемещается между различными «местами» на цифровой карте, эмоциональная разметка (как индивид воспринимает те или иные элементы цифрового пространства)). По результатам формализованного опроса из базы случайным образом будут отобраны респонденты из различных типологических групп, выделенных по критерию интенсивности использования цифровых ресурсов самосохранения (n=30). Отбор будет осуществляться методом стратифицированной рандомизации для обеспечения представленности ключевых типов. Отобранным респондентам будет предложено описывать в режиме реального времени все этапы реализации самосохранительного поведения, начиная от осознания проблемной ситуации, через поиск и сбор информации о ней (выявление цифровых акторов, признание авторитетов, формирование доверия) к принятию решения и действию, направленным на ее разрешение. Панель участников будет сформирована на 1 месяц. Участники и команда проекта работают через закрытый канал и групповой чат в мессенджере и облачную форму, где фиксируются результаты. По массиву данных (скриншоты, видео, тексты, транскрипты аудиосообщений участников) реконструируются реальные траектории самосохранительного поведения от столкновения с проблемной ситуацией до действия по ее разрешению. Планируется представление цифровой карты, отражающей доминирующие модели самосохранительного поведения в цифровой среде, этапы, используемые ресурсы, а также сопряженные с моделями риски и преимущества для здоровья.
5. Экспериментальная онлайн-этнография. Метод заключается в протоколировании цифрового взаимодействия человека с искусственным интеллектом. Данное взаимодействие будет смоделировано реалистичными стартовыми промптами, которые отражают барьеры самосохранения в цифровой среде: 1) институционально-организационные («Не могу записаться к нужному специалисту», «Не понимаю, какие анализы нужно сдать по ОМС»); 2) когнитивно-информационные («Боюсь идти к врачу из-за возможного диагноза», «Стыдно спросить о «постыдных» симптомах»); 3) ресурсные («Нет денег на платного врача/лекарства», «Нет времени на визит в клинику»). Выборка включает 300 респондентов, равномерно распределённых по трём экспериментальным группам (по 100 человек в каждой), соответствующим типам барьеров самосохранения. Каждый участник проходит однократное взаимодействие по соответствующему промпту с последующей субъективной оценкой. Эмпирическую базу составят полные лог-файлы взаимодействия и

данные полуформализованных интервью с количественными оценками. Лог-файлы будут проанализированы посредством дискурс-анализа и обоснованной теории для реконструкции типовых сценариев взаимодействия и критических поворотных точек. Оценка эффективности взаимодействия для преодоления барьеров или генерации новых рисков (дезинформация, склонность к самостоятельной постановке диагноза и последующему лечению, иллюзия решения проблемы, эскалация тревоги и др.) будет осуществлена через статистическое сравнение оценок между группами с разными стартовыми промптами.

6. Для количественного измерения неосознанных, автоматических ассоциаций между цифровой средой и концепциями контроля/тревоги, безопасности/риска будет использован имплицитный ассоциативный тест (ИАТ). Этот метод дополнит данные глубинных интервью и опросов, позволяя верифицировать гипотезы, которые сложно проверить прямыми вопросами: действительно ли у «активных пользователей» сильна ассоциация «цифровая среда → когнитивный риск (тревога, выгорание)», действительно ли у людей, декларирующих полный контроль над своим цифровым поведением (в интервью), на имплицитном уровне сохраняется сильная и быстрая ассоциация между цифровыми стимулами (например, «уведомление») и понятиями хаоса и тревоги. Объектом исследования выступают участники экспериментальной онлайн-этнографии (объем выборки – 300 человек). Респонденты случайным образом распределяются в одну из двух экспериментальных подгрупп. Первая подгруппа пройдет тест, направленный на измерение ассоциаций между цифровой средой и ощущением контроля/перегрузки. Вторая подгруппа пройдет тест, измеряющий ассоциации между цифровой заботой о здоровье и типами рисков (техническими/ментальными).
7. LLM Red Teaming (проверка гипотезы о способности генеративного ИИ повышать уязвимость в сфере самосохранения). Этапы реализации: а) формирование экспертной группы: создание коллегии из 15–20 практикующих российских врачей (терапевты, педиатры, гинекологи) для слепой оценки ответов генеративных моделей ИИ; б) формирование датасета: разработка набора из 150–200 типичных медицинских вопросов, релевантных для российского контекста. Вопросы будут сформированы на основе анализа популярных поисковых запросов в Яндекс.Вордстат и данных пациентских форумов; в) сбор данных: сбор ответов на каждый вопрос от четырех ключевых для российского рынка чат-ботов: YandexGPT (через Алису), GigaChat (от Сбера), GPT-4o (OpenAI), Gemini (Google), DeepSeek; г) слепая оценка: врачи-эксперты анонимно (не зная, какой бот дал ответ) оценят каждый ответ по адаптированной шкале, основанной на российских клинических рекомендациях и стандартах оказания медицинской помощи. Ответы будут классифицироваться как «Приемлемые» и «Проблемные» с подкатегориями («Небезопасный», «Содержит неверную информацию», «Отсутствует важная информация» и т.д.), д) анализ данных: будет проведен статистический анализ (критерий хи-квадрат, z-тесты для пропорций) для сравнения моделей между собой по общему уровню проблемных ответов и по отдельным категориям рисков.
8. Анализ цифровых следов для отслеживания типичных паттернов цифровой активности в сфере самосохранения методом сравнительного анализа временных рядов агрегированных анонимизированных поисковых запросов с использованием открытых платформ Google Trends и Яндекс.Wordstat. Будут анализироваться а) запросы про навыки обращения с цифровой медициной и

иными цифровыми ресурсами в сфере здоровья – для отображения барьеров коммуникации между системой и человеком: навигационные («как записаться к врачу через госуслуги пошагово»), интерпретационные («как читать результаты анализа крови из личного кабинета»), технические («как пользоваться фитнес-браслетом»), критические («можно ли доверять отзывам о врачах в интернете») и др.; б) запросы самодиагностики и самоназначения / приобретение препаратов («симптомы», «что принять», «как лечить» и т.п), в частности, с маркерами стоимости («бесплатно», «дешевые аналоги», «по полису ОМС», «сколько стоит операция»); в) запросы как индикаторы самочувствия с привязкой к информационным событиям и урбанистической среде.

Общий план работы на весь срок выполнения Проекта 2026 и ожидаемые результаты:

2026 г.

1. Разработка теоретико-методологических оснований исследования динамики самосохранительных стратегий россиян в условиях интенсивной цифровизации. Ревизия и систематизация подходов а) к анализу практик заботы о здоровье и безопасности в цифровой среде, б) к изучению рисков для здоровья и благополучия, продуцируемых процессами цифровизации.
2. Приложение концепции уязвимости к анализу заботы о здоровье в условиях цифровизации. Обоснование цифровой среды как источника уязвимости, вскрытие основных линий формирования уязвимостей в развитие идей цифровой структурной уязвимости Д. Лэптон и П. Конрада, с учетом специфики процессов цифровизации в российском обществе.
3. Разработка дизайна, программы и инструментария качественных и количественных эмпирических исследований. Обоснование способа формирования выборочных совокупностей. Определение способ рекрутинга информантов для глубинных интервью, экспертов для тестирования генеративных моделей ИИ.
4. Проведение полевых этапов эмпирических исследований, направленных:
 - а. на описание моделей самосохранительного поведения и стратегий самосохранения, формирующихся в условиях цифровой реальности, среди населения с различной степенью интенсивности использования цифровых ресурсов самосохранения («цифровые исключенные (аутсайдеры)», «нерегулярные пользователи», «активные пользователи» (глубинные интервью, критериальный отбор с учетом территории проживания, объем выборки определяется принципом теоретического насыщения; стимулированное логирование цифровой активности (Digital tracing) добровольцев. Территории проведения исследования – Пермский край, Нижегородская область, Новосибирская область);
 - б. на фиксацию типичных паттернов цифровой активности в сфере самосохранения (анализ цифровых следов пользователей русскоязычного сегмента сети Интернет),
 - с. проверку гипотезы о способности генеративного ИИ повышать уязвимость в сфере самосохранения (LLM Red Teaming с привлечением экспертов),

- d. типизацию стратегий самосохранения уязвимых групп в условиях интенсивной цифровизации здравоохранения, определение баланса между цифровым ресурсом и цифровыми рисками в их стратегиях (глубинные интервью и картографирование рисков и ресурсов цифрового пространства, формирование выборки по критерию теоретического насыщения, частичное покрытие выборки Проекта 2023 – повторные интервью).
- 5. Обработка и анализ собранных данных. Подготовка публикаций в ведущих рецензируемых изданиях. Представление результатов исследования на международных и всероссийских научно-практических конференциях. Организация и проведение специальной секции в рамках Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития человеческого потенциала в современном обществе» (ПГНИУ).

2027 год

1. Разработка дизайна эмпирического исследования методом репрезентативного всероссийского формализованного онлайн-опроса на основе результатов, полученных в первый год выполнения проекта. Обоснование структуры индекса цифровой зрелости применительно к сфере самосохранения, адаптация методики оценки субъективно воспринимаемого риска к изучению рисков ментальному здоровью, формируемых цифровой средой. Проектирование и тестирование виньеток. Обоснование выборки исследования (не менее 2400 человек, все федеральные округа РФ).
2. Проведение полевого этапа исследования (создание электронной анкеты на специализированной платформе, набор респондентов методом ривер-сэмплинг, контроль структуры выборки). Подготовка данных для анализа.
3. Анализ данных формализованного опроса с применением логики нечетких множеств, нейросетевого моделирования, методов многомерного статистического анализа.
4. Разработка дизайна исследования методом самоотчетов о цифровой активности в сфере заботы о здоровье и личной безопасности. Рекрутинг участников панели для картографирования цифрового поведения (n=30). Проведение полевого этапа. Описание реальных траекторий самосохранительного поведения от столкновения с проблемной ситуацией до действия по ее разрешению, соотнесение нарративов и интерпретация индивидов с их реальным поведением для уточнения моделей и стратегий самосохранения.
5. Разработка дизайна и инструментария полевого исследования в экспериментальном формате на выборке «цифровых аборигенов» (вовлеченные в цифровые технологии, в т.ч. в сфере самосохранения). Формирование выборки исследования (n=300). Проведение экспериментальной онлайн-этнографии и имплицитного ассоциативного теста (ИАТ) с целью протоколирования цифрового взаимодействия человека с искусственным интеллектом и неосознаваемыми установки по отношению к нему и цифровой среде в принципе.
6. Подготовка публикаций в рецензируемых журналах. Представление результатов исследования на международных и всероссийских научно-практических конференциях. Организация и проведение специальной секции в рамках Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции

«Актуальные проблемы развития человеческого потенциала в современном обществе» (ПГНИУ).

Результаты

2026 г.

1. Авторская теоретико-методологическая рамка анализа самосохранительного поведения индивида как динамического процесса его взаимодействия с цифровой средой.
2. Теоретически обоснованная расширенная модель уязвимости, смещающая фокус с уязвимости здоровья на уязвимость индивида, определяемую действием факторов цифровой среды, в частности, инфраструктурной и когнитивной зависимостью индивида от действия цифровых агентов.
3. Укорененная в данных типология моделей самосохранительного поведения и стратегий самосохранения, формирующихся в условиях цифровой реальности, среди населения с различной степенью интенсивности использования цифровых ресурсов самосохранения.
4. Характеристика особенностей восприятия россиянами цифровых ресурсов заботы о здоровье и личной безопасности, в т.ч. искусственного интеллекта, в континууме «проактивная забота – компенсация дисфункций традиционной системы обеспечения здоровья»
5. Набор детализированных цифровых биографических кейсов, раскрывающих особенности включения цифровизации в ткань повседневных самосохранительных стратегий современного человека.
6. Описание типичных паттернов цифровой поисковой активности россиян в сфере самосохранения, перечень зон рисков и возможностей.
7. Построенная на дополнении результатов Проекта 2023 укорененная в данных теория самосохранительных стратегий уязвимых групп. Детализированное описание профилей цифровой вовлеченности и восприятия цифровой среды в рамках различных самосохранительных стратегий отдельных уязвимых подгрупп.
8. Результаты оценки рискогенного потенциала генеративного искусственного интеллекта в сфере самосохранения. Рекомендации, разработанные совместно с экспертным сообществом, по взаимодействию с ИИ в пространстве здоровья и медицины.
9. Методические материалы проведения полевых исследований самосохранения в условиях цифровизации.
10. Статьи в изданиях, индексирующихся в Scopus и RSCI (5 статей).
11. Выступления членов исследовательского коллектива на международных и всероссийских конференциях (не менее 10); специальная секция, посвященная результатам первого года проекта, в рамках Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития человеческого потенциала в современном обществе» (ПГНИУ).

2027 г.

1. Обоснованные методические подходы к анализу самосохранительного поведения в условиях цифровизации общества, апробированные на российских выборках.

Валидизированный инструментарий исследования уровня цифровой зрелости применительно к сфере самосохранения и оценки субъективно воспринимаемых рисков ментальному здоровью, формируемых цифровой средой

2. Построенная на материалах всероссийского опроса типология поведенческих стратегий россиян в сфере здоровьесбережения и безопасности (самосохранительных стратегий) в условиях цифровизации; система факторов и закономерностей, описывающих воздействие цифровой среды на динамику самосохранительных ориентаций (ценностный компонент) и поведения.
3. Новые эмпирические данные, позволяющие определить роль новых акторов пространства самосохранения и цифровой медиатизации заботы в модификации самосохранительных практик россиян.
4. Детализированное описание реальных траекторий самосохранительного поведения на основе апробированного нового метода самоотчетов о цифровой активности в сфере здоровья и безопасности.
5. Социологический портрет особой социальной группы – «цифровых аборигенов», составленный на основе описания их социальных установок и цифровой самосохранительной активности.
12. Статьи в изданиях, индексирующихся в Scopus и RSCI (5 статей).
13. Выступления членов исследовательского коллектива на международных и всероссийских конференциях (не менее 10); специальная секция, посвященная результатам первого года проекта, в рамках Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития человеческого потенциала в современном обществе» (ПГНИУ).

План работы на первый год выполнения проекта (в том числе указываются запланированные командировки (экспедиции) по проекту)

Планируемое на первый год содержание работы каждого основного исполнителя проекта (включая руководителя проекта)